

普罗帕酮使用后的茶碱毒性— 药物相互作用的证据

普罗帕酮主要由肝脏代谢,为细胞色素酶 $P_{450}11D$ 所催化。许多肝代谢药与本品有相互作用。本文报道 1 例普罗帕酮与茶碱同时服用致茶碱浓度升高产生毒性的病例。

患者,男性,71 岁,有慢性阻塞性肺病,慢性支气管炎,心绞痛和非持续性室性心动过速反复发作晕厥病史。患者自 1984 年以来服用茶碱 300 mg,2 次/d 治疗,茶碱浓度稳定(10.2~12.8mg/L)。1990 年 2 月 22 日始服普罗帕酮 150mg,3 次/d,6 周后茶碱浓度为 19.0 mg/L。患者诉食欲低、虚弱并心率由原 95 次/min 增至 120 次/min。于 1990 年 4 月 26 日停用普罗帕酮,4 月 29 日测得茶碱浓度 10.8mg/L。5 月 2 日再度用普罗帕酮 150mg,3 次/d 治疗,此时茶碱浓度为 12.8mg/L。5 月 9 日茶碱浓度再次升高至 17.5mg/L,随后茶碱剂量

减低至 200mg,2 次/d,普罗帕酮剂量不变,茶碱浓度为 11.9mg/L。

茶碱与普罗帕酮代谢都由细胞色素 P_{450} 酶系所调节。两药享有共同的同功酶,可能普罗帕酮对细胞色素 P_{450} 同功酶起到强力抑制作用而妨碍了茶碱的氧化代谢。本文患者服用普罗帕酮后茶碱浓度几乎加倍(从 10.2mg/L~19.0mg/L),结果出现茶碱中毒症状。为避免可能产生的副作用,建议茶碱与普罗帕酮合用时应监测血清茶碱浓度,并适当减少茶碱剂量以维持最佳给药方案。

(杨淑英摘译自 Belle L Lee, et al. *Clin Pharm and Ther*, 1992, 51(3):353 王佳英校)

(收稿:1993-03-12 修回:1993-05-25)

息斯敏的禁忌症

由于息斯敏有潜在的威胁生命的药品相互作用,因而美国 FDA 于 1992 年 10 月批准修改息斯敏的说明书。

修改后的说明书中,由于可能有不良的心脏反应,禁止息斯敏与抗霉菌药酮康唑和伊曲康唑(Itraconazole)或大环内酯抗生素红霉素同时使用。

不管什么原因包括用药过量引起息斯敏血浆浓度升高,不良的心脏反应都可能出现。联合用药,能使息斯敏的代谢发生变化,而导致危险的血浆浓度。不良的心脏反应有:心电图 QT/QTc 间距延长、心动停止、Torsades de Pointes 及其它室性心律不齐。

息斯敏也不能与其它大环内酯抗生素如醋竹桃霉素、克红霉素或阿奇红霉素合并使用。

息斯敏说明书的修改是由该药的生产厂 Titusville, N. J. 杨森制药厂最近写给 FDA 两份报告引起的。两位经历了 Torsades de Pointes 性昏厥的病人,需住院治疗。其中一位服用了息斯敏及红霉素,另一位病人服用了息斯敏、酮康唑及红霉素。

人的药代动力学初步研究数据也表明酮康唑能使息斯敏的代谢显著改变,结果使息斯敏及其活性代谢物

脱甲息斯敏的血浆浓度升高。体内试验也已发现伊曲康唑有类似反应。

单独用低剂量(20~30mg/d)的息斯敏,曾有少数心脏不良反应的报道。如果出现了心脏不良反应,只要病人的 QT/QTc 间距有延长,就应予以监测。

1992 年 9 月份出的 FDA Medical Bulletin 曾报道过另一种无镇静作用的抗组织胺药特非那定,其血液浓度升高能产生相似的心脏反应。当时特非那定的说明书,禁忌与酮康唑、伊曲康唑及红霉素同用。FDA 正在审查新的可能支持禁忌与克红霉素及醋竹桃霉素同时使用的数据。

医务人员应保证病人不将息斯敏或特非那定同时与酮康唑、伊曲康唑、红霉素或任何能引起问题的其它药物共同使用。

杨森制药厂于 1992 年 10 月 26 日给医务人员发信,解释息斯敏说明书改变的原因。

(杨景勋译自 FDA Medical Bulletin, 1993, 23(1):2)

(收稿:1993-06-20)